·调查分析·

癌症患者临终沟通障碍现状、影响因素分析及护理启示*

朱雅麟[1a],李炎[1b],石琳琳[2],柴守霞[3]

(1十堰市人民医院 湖北医药学院附属人民医院1a康复科,1b门诊部,湖北十堰,442000;2武昌理工学院,湖北武汉,430223;3湖北医药学院护理学院,湖北十堰,442000)

[摘要] **目的** 探讨癌症患者临终沟通障碍现状,分析其影响因素,为临床医护人员实施家庭干预提供理论依据。**方法** 本研究为横断面研究,采用方便抽样法,选取2022年12月—2023年5月本市3所三级甲等综合医院的354例癌症患者,使用一般资料问卷、中文版临终沟通障碍-家庭版量表(difficulties in end of life discussions-family inventory,DEOLD-FI)、家庭功能评定量表(family assessment device,FAD)和中文版癌症自我管理效能感量表(strategies used by people to promote health,SUPPH)对其进行调查。采用方差分析、独立样本t检验、Pearson相关分析进行单因素分析;采用多重线性回归分析癌症患者临终沟通障碍的影响因素。**结果** 320例癌症患者完成研究。癌症患者临终沟通障碍得分为(76.5±16.0)分,处于中等水平。多重线性回归分析显示,年龄越大者、自我管理效能感越高者、家庭功能越好者其临终沟通障碍越低,合并3种及以上基础疾病者其临终沟通障碍最低。**结论** 癌症患者临终沟通障碍处于中等水平,医护人员应针对原因,通过家庭、医院和社工等多方合作,降低癌症患者的临终沟通障碍水平。

[关键词] 癌症患者;临终沟通障碍;家庭功能;自我管理效能感;护理;横断面研究

[中图分类号] R473.73 [文献标志码] A [文章编号] 1671-8283(2025)08-0001-08 [DOI] 10.3969/j.issn.1671-8283.2025.08.001

Current situation and analysis of factors influencing end-of-life communication with cancer patients and nursing implication

Zhu Yalin[1a],Li Yan[1b],Shi Linlin[2],Chai Shouxia[3]//Modern Clinical Nursing,-2025,24(8):1.

(1a. Department of Rehabilitation and 1b. Department of Outpatient of Shiyan Renmin Hospital,Hubei University of Medicine,Shiyan 442000,Hubei Province,China. 2. Wuchang University of Technology,Wuhan 430223,Hubei Province,China. 3. School of Nursing,Hubei University of Medicine,Shiyan 442000,Hubei Province,China.)

[**Abstract**] **Objective** To investigate current situation and the factors influencing end-of-life communications in families having cancer patients in order to provide advices for family intervention. **Methods** In this cross-sectional study,convenience sampling method was used to select 354 cancer patients from three Tier-IIIA hospitals in Shiyan between December 2022 and May 2023. Data were collected using a general data questionnaire,the difficulties in end-of-life discussions-family inventory(DEOLD-FI),family assessment device(FAD),and the Chinese version of the strategies used by people to promote health(SUPPH)scale . Univariate analysis included analysis of variance,independent sample t-test,and Pearson correlation analysis. Multiple linear regression identified

目前,我国癌症患者发病率和死亡率呈明显上升趋势,2022年中国新增约4 820 000例癌症病例、3 210 000例癌症死亡病例[1]。国内外对于家庭背景下的临终沟通概念暂无统一界定,常定义为从癌症诊断到死亡的所有对话,包括爱、个体角色和关系、信仰、日常互动等[2]。沟通障碍指因先天或后天因素造成个体在接收、传递、处理或理解口语、非口语或符号

[基金项目] *本课题为2022年度湖北省教育厅哲学社会科学研究项目,项目编号为22Y121。

[收稿日期] 2024-10-26

[作者简介] 朱雅麟(1998-),女,主管护师,硕士,主要从事康复护理工作。

[通信作者] 柴守霞,副教授,硕士,E-mail:xilanhua666@163.com。

中国知网 https://www.cnki.net

the factors associated with end-of-life communication difficulty with cancer patients. **Results** A total of 320 cancer patients completed the study. The score of end-of-life communication with cancer patients was (76.5 ± 16.0) at medium level. Multiple linear regression analysis revealed that individuals who were older, had higher self-management efficacy, and had better family functioning experienced lower barriers to end-of-life communication. Those with three or more comorbidities experienced the lowest barriers to end-of-life communication. **Conclusion** This study has found that there is a moderate end-of-life communication difficulty with cancer patients. Medical professionals should focus on these reasons and organize multidisciplinary collaboration with families, hospitals and social workers is essential to address the challenges.

[**Key words**] cancer patients; end-of-life communication; family function; self-efficacy; nursing; cross-sectional study

等方面存在的能力缺陷。其中,因疾病、身心障碍或脑部损伤所造成的沟通障碍独立归于医疗性沟通障碍[3]。美国、加拿大、澳大利亚等国家较早开展癌症患者临终沟通方面的相关研究[4]。日本[5]、德国[6]、以色列[7]等国家也逐渐认识到对于晚期癌症患者家庭沟通的重要性,陆续开展相关研究。中国由于传统文化及多种因素影响通常回避临终沟通,人们对临终沟通不够重视[2]。其中,患者的消极态度(例如对死亡的恐惧或焦虑)会影响临终沟通[8];同时,抑郁情绪也会影响患者进行临终沟通[9]。癌症患者通常在终末期才进行临终沟通(建议在疾病早期进行),这往往导致患者在生命的最后时刻失去宝贵的时间来开展临终沟通[10]。建立以患者为中心的临终沟通,可以向患者及家属介绍姑息治疗,建立医患信任、控制症状、增强应对并指导决策[11],减轻患者及其家属在临终阶段的恐惧,帮助患者和家人建立良好的家庭关系,提供实用的信息和情感支持[12-13]。国外研究显示[14-15],收入、年龄、心理状态、家庭功能和自我管理效能感均会影响癌症患者的临终沟通。然而,由于国外文化及其研究对象不同,而且国内关于临终沟通的研究较少,突破生死话题是临终沟通推广和发展的关键[16]。本研究旨在探讨癌症患者临终沟通障碍的现状及其影响因素,以期为降低癌症患者临终沟通障碍提供理论依据。

1 对象与方法

1.1 研究对象

本研究为横断面研究,采用方便抽样法,选取2022年12月—2023年5月本市3所三级甲等综合医院符合纳排标准的癌症患者为研究对象。纳入标准:①经病理诊断为癌症分期Ⅲ~Ⅳ期者;②年龄≥18岁者;③精神状况正常,无认知、阅读及沟通障碍者。排除标准:①对自身癌症诊断不知情、家属要求病情保密者;②身体过度虚弱不能配合此项调查者。根据孙振球等[17]主编《医学统计学》中样本量的计算方法,样本量一般取自变量个数的10~20倍,本研究中一般资料调查表包括17个自变量,加上家庭功能和自我管理效能感2个变量,共计19个自变量,考虑5%的无效问卷,故本研究所需样本量为200~400例。本研究实际收集320例。本研究已通过国药东风总医院(批号:LW-2022-012)和湖北医药学院伦理委员会批准(批号:2023-RE-006)。患者均知情同意参与本研究。

1.2 研究工具

1.2.1 一般资料调查表 在参考文献[2]基础上自行设计,包括性别、年龄、婚姻状况、文化程度、医学背景、居住地、医保类型、宗教信仰、家庭年收入、肿瘤类型、主要照顾者、子女个数、吸烟、饮酒、合并基础疾病、患癌时间、肿瘤分期。

1.2.2 中文版临终沟通障碍-家庭版量表(difficulties in end of life discussions-family inventory, DEOLD-FI) 该量表于2021年由BETKER等[18]编制,原量表的Cronbach α系数为0.93,主要用于评估癌症患者临终沟通障碍程度。2022年由朱雅麟等[19]汉化,汉化后的量表包括5个维度:情感负担(6个条目),消极态度(6个条目),家庭负担(5个条目),死亡恐惧(3个条目),沟通能力(2个条目),共计22个条目。条目采用Likert 6级评分法,"1~6"分依次为"非常不同意"到"非常同意",总分22~132分,分数越高代表谈论自己的死亡话题的障碍程度越高。中文版DEOLD-FI的Cronbach α系数为0.897。本研究该量表的Cronbach α系数为0.907。

1.2.3 中文版癌症自我管理效能感量表(strategies used

中国知网 https://www.cnki.net

by people to promote health,SUPPH) 该量表于1996年由美国LEV等[20]编制,用于评估癌症患者自我管理效能感。2011年由钱会娟等[21]汉化,包括3个维度:自我减压(3个条目)、自我决策(10个条目),正性态度(15个条目),共计28个条目。条目采用Likert 5级评分法,总分28~140分,总分越高代表自我管理效能感越好,可划分为低、中、高3个等级,得分范围分别为≤65分、66~102分、≥103分,量表具有较好的信度与效度。本研究该量表的Cronbach α系数为0.968。

1.2.4 家庭功能评定量表(family assessment device,FAD) 该量表于1983年由EPSTEIN等[22]编制,用于癌症患者家庭功能的测量。2013年由国内学者李荣风等[23]修订,量表有7个维度:问题解决(6个条目)、沟通与交流(9个条目)、家庭角色(11个条目)、情感反应(6个条目)、情感参与(7个条目)、行为控制(9个条目)以及总的功能(12个条目),共计60个条目。条目采用Likert 4级评分法,1分(非常同意)~4分(非常不同意),总分60~240分,量表的总分越低代表家庭功能越好,量表具有较好的信度与效度。本研究该量表的Cronbach α系数为0.907。

1.3 资料收集

本研究由经过统一培训的2名研究员负责调查。采用现场调查方式,调查时向患者说明量表填写的方法,由患者独立填写。完成后研究员立即收回所有问卷,并检查是否有遗漏缺填内容,发现存在疑问之处,及时与患者进行核对。本研究共发放调查问卷354份,回收有效问卷320份(无效问卷包括患者由于治疗或个人身体心理情况主动要求终止调查),问卷有效回收率为90.4%。

1.4 统计学方法

采用IBM SPSS Statistics 23.0录入数据并进行数据分析。计量资料均符合正态分布以均数±标准差描述,计数资料以频数(百分率)描述;数据采用方差分析、独立样本t检验和Pearson相关分析;采用多重线性回归分析癌症患者临终沟通障碍影响因素,变量筛选采用输入法,检验水准设为α=0.05。

2 结果

2.1 癌症患者人口学特征

320例癌症患者中,男182例(56.9%),女138例(43.1%),年龄24~88岁,平均(61.3±10.7)岁,其他信息见表2。

2.2 癌症患者临终沟通障碍现状、各维度得分和条目得分情况

癌症患者临终沟通障碍得分为(76.5±16.0)分,条目平均分为(3.5±0.7)分,处于中等水平,各维度得分情况见表1。量表条目得分最高的前3项为第21项"因为当前有更重要的事情"(4.7±1.1)分;第14项"我想关注生而不是死"(4.7±1.0)分;第9项"因为我认为他/她不愿意相信我的生命即将结束"(4.5±1.2)分。

表1 癌症患者临终沟通障碍-家庭版量表各维度得分 (n=320;分,$\bar{X}\pm S$)

维度	条目数(个)	理论值范围	得分	条目均分	排序
情感负担	6	6~36	17.7±5.9	3.0±0.1	5
消极态度	6	6~36	23.9±4.8	4.0±0.8	1
家庭负担	5	5~30	17.4±4.6	3.5±0.9	3
死亡恐惧	3	3~18	11.5±6.3	3.8±2.1	2
沟通能力	2	2~12	6.1±2.4	3.1±1.2	4

2.3 癌症患者家庭功能与自我管理效能感得分情况

320例癌症患者家庭功能总得分为(123.7±21.8)分,自我管理效能感总得分为(86.3±18.7)分,均处于中等水平。

2.4 不同人口学特征的癌症患者临终沟通障碍得分比较

不同人口学特征的癌症患者临终沟通障碍得分比较见表2。由表2可见,性别、年龄、吸烟、合并基础疾病4个变量组间比较,差异具有统计学意义(均P<0.05);其他13个自变量组间比较,差异无统计学意义(均P>0.05)。

2.5 癌症患者临终沟通障碍与自我管理效能感、家庭功能的相关性分析

癌症患者临终沟通障碍总分与自我管理效能感总分及其各维度均呈负相关(均P<0.001),与家庭功能总分及其各维度均呈正相关(均P<0.001),见表3。

2.6 癌症患者临终沟通障碍影响因素的多重线性回归分析

本研究以临终沟通障碍总分为因变量,将单因素分析中组间差异有统计学意义的6个变量(包括

中国知网 https://www.cnki.net

表2 不同人口学特征的癌症患者临终沟通障碍得分比较 (n=320;分,$\bar{X}\pm S$;n/%)

项目	n	临终沟通障碍得分	统计值	P
性别				
男	182(56.9)	74.4±15.4	t=−2.698	0.007
女	138(43.1)	79.2±16.3		
年龄(岁)				
18~40	10(3.1)	82.1±15.2		
41~60	151(47.2)	79.5±15.8	F=6.930	0.001
≥61	159(49.7)	73.2±15.5		
婚姻状况				
已婚	280(87.5)	76.2±15.7		
未婚	9(2.8)	79.2±20.0	F=0.290	0.748
离异或丧偶	31(9.7)	77.9±17.0		
文化程度				
小学及以下	119(37.2)	76.2±16.3		
初中	101(31.6)	76.8±16.1	F=0.082	0.970
高中或中专	67(20.9)	76.9±16.5		
大专及以上	33(10.3)	75.5±13.7		
医学背景				
有	111(34.7)	75.5±17.0	t=−0.823	0.411
无	209(65.3)	77.0±15.4		
居住地				
城市	231(72.2)	76.0±15.5	t=−0.843	0.400
农村	89(27.8)	77.7±17.1		
医保类型				
职工医保	154(48.1)	75.0±15.4		
居民医保	158(49.4)	78.9±16.3	F=1.618	0.200
自费	8(2.5)	74.0±18.7		
宗教信仰				
有	17(5.3)	72.8±11.3	t=−1.335	0.197
无	303(94.7)	76.7±16.2		
家庭年收入(万元)				
<2	95(29.7)	77.1±16.5		
2~4	79(24.7)	77.9±15.3	F=0.741	0.478
>4	146(45.6)	75.3±15.9		
肿瘤类型				
消化系统肿瘤	120(37.5)	75.9±14.9		
呼吸系统肿瘤	93(29.1)	76.4±17.2	F=1.425	0.236
妇科肿瘤	64(20.0)	79.7±15.4		
其他	43(13.4)	73.4±16.6		
主要照顾者				
无	4(1.2)	73.0±15.4		
配偶	213(66.6)	77.2±15.7		
子女	80(25.0)	74.6±16.6	F=0.701	0.591
父母	6(1.9)	71.8±7.3		
其他	17(5.3)	79.4±18.9		
子女个数				
无	9(2.8)	76.3±18.4		
1个	108(33.8)	78.0±16.1	F=0.712	0.545
2个	121(37.8)	76.4±15.6		
3个及以上	82(25.6)	74.6±16.1		
吸烟				
无	180(56.3)	79.2±15.4		
超过30d以上未吸烟	122(38.1)	73.1±16.2	F=5.999	0.003
仍吸烟	18(5.6)	72.8±14.9		
饮酒				
无	165(51.6)	78.1±16.0		
超过30d以上未饮酒	145(45.3)	74.9±15.7	F=2.034	0.132
仍饮酒	10(3.1)	71.9±16.6		
合并基础疾病				
无	86(26.9)	81.6±16.2		
1种	105(32.8)	75.7±15.7	F=4.599	0.004
2种	56(17.5)	75.0±13.5		
3种及以上	73(22.8)	72.8±16.6		
患癌时间(年)				
<1	202(63.1)	77.5±15.6		
1~3	80(25.0)	75.8±16.2	F=1.560	0.199
4~5	23(7.2)	75.2±17.8		
>5	15(4.7)	68.7±15.6		
肿瘤分期				
Ⅲ期	134(41.9)	78.1±15.6	t=1.584	0.114
Ⅳ期	186(58.1)	75.3±16.1		

表3 癌症患者临终沟通障碍总分与自我管理效能感、家庭功能总分及其各维度的相关性分析 (n=320,r)

项目	临终沟通障碍总分
自我管理效能感总分	−0.608*
自我决策	−0.462*
正性态度	−0.573*
自我减压	−0.618*
家庭功能总分	0.786*
问题解决	0.649*
沟通与交流	0.684*
家庭角色	0.505*
情感反应	0.643*
情感参与	0.588*
行为控制	0.498*
总的功能	0.709*

注:*P<0.001。

中国知网 https://www.cnki.net

性别、年龄、吸烟、合并基础疾病、自我管理效能感、家庭功能)作为自变量进行多重线性回归分析,见表4。由表4可见,模型总的检验结果:F=64.987,P<0.001,调整R^2=0.667,6个变量(自我管理效能感、家庭功能、性别、年龄、吸烟、合并基础疾病)解释临终沟通障碍总变异的68.0%。

表4 癌症患者临终沟通障碍影响因素的多重线性回归分析 (n=320)

项目	偏回归系数	标准误	标准回归系数	t	P
常量	48.780	7.600		6.600	<0.001
性别(以男性为参照)					
女性	−1.904	1.470	−0.059	−1.295	0.196
年龄(以18~40岁为参照)					
41~60岁	−7.371	3.111	−0.231	−2.369	0.018
≥61岁	−8.905	3.147	−0.280	−2.830	0.005
吸烟(以不吸烟为参照)					
超过30d以上未吸烟	−2.840	1.499	−0.087	−1.895	0.059
仍吸烟	−2.934	2.534	−0.042	−1.158	0.248
合并基础疾病(以无合并基础疾病为参照)					
1种	−1.395	1.371	−0.041	−1.017	0.310
2种	0.363	1.632	0.009	0.222	0.824
3种及以上	−3.882	1.560	−0.102	−2.489	0.013
自我管理效能感总分	−0.180	0.035	−0.212	−5.217	<0.001
家庭功能总分	0.469	0.030	0.640	15.755	<0.001

注:R^2=0.680,调整后的R^2=0.667,F=64.987,P<0.001。

3 讨论

3.1 癌症患者临终沟通障碍得分处于中等水平

本研究显示,癌症患者临终沟通障碍得分为(76.5±16.0)分,处于中等水平。其原因可能是由于调查的研究对象为中晚期癌症患者,对于疾病的发展,患者内心处于癌症的接受期。BENDEL等[14]的研究采用临终对话-期望量表(end-of-life conversations-expectations scale,EOLC-E)进行调查,发现癌症患者在进行临终沟通时,对死亡的恐惧是临终沟通的重要障碍因素,但进行临终对话可能会减少其对潜在情感负担的恐惧。研究显示[24],当在非正式场合公开谈论临终问题时,受访者希望获得实质性的个人解脱,但是由于家属在场,很难达到个人情感的释放。本研究中,≥61岁的癌症患者约占总人数的一半(49.7%),大多数为老年人,其对临终和死亡话题具有一定的接受度。程春燕等[25]研究显示,老年癌症患者在应对癌症这一强大应激事件时虽遭受癌症带来的痛苦,但多数患者仍对生活充满希望。本研究量表中"消极态度"维度的得分(4.0±0.8)分最高。其中代表条目分别为第21项"因为当前有更重要的事情"、第14项"我想关注生而不是死"、第9项"因为我认为他/她不愿意相信我的生命即将结束"。可能是考虑到疾病的无法治愈性,以及患病后患者的抑郁程度较高对临终沟通呈现消极态度[26],并且死亡焦虑也会影响晚期癌症患者对安宁疗护的态度[27]。研究显示[28],近一半的癌症患者会因死亡及预期寿命缩短等原因都患有明显的情绪困扰和心理问题;另外一方面,国内癌症患者的死亡教育、早期实施安宁疗护开展相对较晚,在患病早期患者可能还未树立正确的生死观,因而呈现消极态度[28-29]。尽管癌症给患者身体、心理、精神等方面都带来巨大痛苦,但其面对疾病仍存希望[30];特别是年轻患者比年老者对生存的渴望更大[31]。因此,医护人员在工作中可以关注患者对于临终话题的态度,帮助家属和患者搭建沟通桥梁,建议由专业人员主动发起临终对话,其有利于降低患者和照顾者的心理负担。

3.2 癌症患者临终沟通障碍影响因素分析

3.2.1 *年龄* 本研究结果显示,癌症患者的年龄是其临床沟通障碍的影响因素。年龄越大者其临终沟通障碍越低,其中≥61岁的癌症患者临终沟通障碍得分最低,为(73.2±15.5)分,这与RAFFERTY等[32]的研究结果一致。其原因可能是随着年龄的增长,患者对于疾病和死亡的接受度也越来越高。黄培雯等[33]研究表明,60岁以上的癌症患者灵性需求低于60岁以下的癌症患者。另外,研究显示[34],女性乳腺癌患者年龄越大其对癌症的复发恐惧也越低。BALIN等[35]研究也显示,随着人们年龄增长越来越接受死亡的可能性,对死亡的恐惧程度与年龄呈反比。这可能与年龄越大越愿意对该话题进行沟通有关。提示,应更加关注年轻的癌症患者,医护人员在治疗和护理过程中应重点观察患者的心理状态和家庭功能、联合照顾者共同对患者进行家庭干预,促进患者临终沟通的开展。

3.2.2 *合并基础疾病* 本研究结果显示,合并3种及

中国知网 https://www.cnki.net

以上基础疾病者其临终沟通障碍最低($P<0.05$),得分为(72.8±16.6)分,无合并基础疾病的患者临终沟通障碍得分最高,为(81.6±16.2)分。SCHERER等[36]研究显示,癌症合并晚期肾病患者希望进行临终话题的讨论,提高患者生活质量,在患者去世后家庭照顾者的遗憾程度也较低。黎东梅等[37]研究显示,患者所患合并基础疾病数量越多,其代理决策者的预立医疗照护计划参与度越高,有利于更好地引导患者开展临终话题。而护士作为陪伴患者时间最长的群体,能够促进患者及家属做出最佳临终决策[38]。而无合并基础疾病的患者在患癌前对自身健康具有较大信心,且由于之前未患慢性病,对疾病和死亡的接受与准备程度较低,甚至从未与家属谈论过临终相关话题。提示,医护人员与家庭照顾者需更关注无任何合并基础疾病的癌症患者,应尽早开始对患者进行死亡教育。

3.2.3 自我管理效能感 本研究结果显示,自我管理效能感越高者其临终沟通障碍越低($P<0.001$)。可能是因为自我管理效能感较低的癌症患者因自我价值感降低而出现消极应对、面对重大应激事件被动处理的心态,对于即将来临的死亡和死亡话题都呈现回避状态[39]。胡方舟等[40]研究发现,多病共存患者的坚毅水平与自我管理效能感呈正相关,当患者的自我管理效能感越好,坚毅水平也越高,应对困难的能力也越强。MANNE等[41]研究发现,消极情绪或拒绝情绪分享的患者自我管理效能感较低,自我管理效能感低的患者对家庭沟通感受和能力的需求也较低。患者分享癌症相关问题、表达情绪会增强其沟通和管理情绪能力的信心。李婕妤[42]对143对结直肠癌患者及其配偶的沟通影响因素进行调查,结果显示,结直肠癌患者自我管理效能感越高,与家庭照顾者开放式沟通越多,癌症相关问题沟通困难越少。提示,医护人员可通过疾病管理提高患者的自我管理效能感,帮助患者降低临终话题中的沟通障碍。

3.2.4 家庭功能 本研究结果显示,家庭功能越好者其临终沟通障碍越低($P<0.001$)。可能是因为癌症患者的家庭氛围越好、对死亡话题的接受程度和开放程度也越高,能够有效降低患者临终沟通障碍。患者也更愿意与家人或朋友谈论临终前关注的话题,并通过这些话题来向他们表达爱与感激。研究发现[43],配偶作为癌症患者主要照顾者,在患者治疗和护理期间,配偶需要兼顾家庭和工作,当照顾者发生角色冲突时会出现负担过重和消极行为;当家庭内部出现不和谐时,患者的心理负担加剧,整个家庭内部也会出现回避沟通行为。徐瑞等[44]研究发现,提高家庭功能可有效缓解癌症患者的死亡焦虑,为家庭提供一定的社会支持可以促进患者感知生命的意义。医护人员采取干预措施可帮助其改善心理困扰、改变对死亡的认知,以便有利于患者在家庭中进行临终沟通。

4 结论

本研究发现,癌症患者的临终沟通障碍处于中等水平;年龄越大者、自我管理效能感越高者、家庭功能越好者其临终沟通障碍越低,合并3种及以上基础疾病者其临终沟通障碍最低,其是患者临终沟通障碍的影响因素。建议临床医护人员、心理咨询师、志愿者与家庭照顾者等多方合作,制订可行的家庭干预方案,提高患者的生活质量、帮助患者在临终阶段平和幸福地离开,同时也帮助患者家属能够平静地面对亲人的离世。本研究取样仅限于本市3所三级甲等综合医院,样本代表性不足,未来可开展多中心、大样本的研究进一步探讨癌症患者临终沟通障碍的影响因素。

参考文献:

[1] CHANGFA X,XUESI D,HE L,et al. Cancer statistics in China and the United States,2022: profiles,trends and determinants[J]. Chin Med J (Engl.),2022,135(5):584-590.

[2] 朱雅麟,柴守霞,刘一魁,等. 晚期癌症病人临终沟通的研究进展[J]. 护理研究,2023,37(1):98-104.

[3] 梁爱民,王信懿,廖雅姿. 儿童沟通障碍概念与临床筛查诊断的发展与探讨[J]. 医学综述,2020,26(22):4369-4373.

[4] 郜心怡,陈长英,崔盼盼,等. 晚期癌症病人临终沟通模式研究进展[J]. 护理研究,2020,34(12):2140-2144.

[5] HANARI K,SUGIYAMA T,INOUE M,et al. Caregiving experience and other factors associated with having end-of-life discussions: a cross-sectional study of a general

中国知网 https://www.cnki.net

Japanese population[J]. J Pain Symptom Manage, 2021, 61(3):522-530.

[6] HAUN M W, SKLENAROVA H, WINKLER E C, et al. Assessing patient-caregiver communication in cancer-a psychometric validation of the cancer communication assessment tool (CCAT-PF) in a German sample[J]. Support Care Cancer, 2014, 22(9):2473-2478.

[7] BACHNER Y G, MORAD M, SROUSSI C, et al. Direct and indirect predictors of burden among Bedouin caregivers of family members with terminal cancer in Israel[J]. Aging Ment Health, 2020, 24(4):575-581.

[8] 顾婷婷,陈伟芬,薛婷,等. 癌症患者临终沟通准备度量表的汉化及信效度检验[J]. 护理学杂志, 2023, 38(11):101-103.

[9] ZAIDER T I, KISSANE D W, SCHOFIELD E, et al. Cancer-related communication during sessions of family therapy at the end of life[J]. Psychooncology, 2020, 29(2):373-380.

[10] KOH S J, KIM S, KIM J. Communication for end-of-life care planning among Korean patients with terminal cancer: a context-oriented model[J]. Palliat Support Care, 2016, 14(1):69-76.

[11] BACK A L. Patient-clinician communication issues in palliative care for patients with advanced cancer[J]. J Clin Oncol, 2020, 38(9):866-876.

[12] OLSSON M M, WINDSOR C, CHAMBERS S, et al. A scoping review of end-of-life communication in international palliative care guidelines for acute care settings[J]. J Pain Symptom Manage, 2021, 62(2):425-437.

[13] NAGELSCHMIDT K, LEPPIN N, SEIFART C, et al. Systematic mixed-method review of barriers to end-of-life communication in the family context[J]. BMJ Support Palliat Care, 2021, 11(3):253-263.

[14] BENDEL Y, PINQUART M, SCHULZ-QUACH C, et al. Expectations in the communication about death and dying: development and initial validation of the end-of-life conversations-expectations scale[J]. Omega (Westport), 2024, 90(2):710-725.

[15] LARANJEIRA C, DIXE M A, SEMEÃO I, et al. "Keeping the light on": a qualitative study on hope perceptions at the end of life in Portuguese family dyads[J]. Int J Environ Res Public Health, 2022, 19(3):1561.

[16] LEI L, GAN Q, GU C, et al. Life-and-death attitude and its formation process and end-of-life care expectations among the elderly under traditional Chinese culture: a qualitative study[J]. J Transcult Nurs, 2022, 33(1):57-64.

[17] 孙振球,徐勇勇.医学统计学[M]. 4版.北京:人民卫生出版社, 2014:524-527.

[18] BETKER L, NAGELSCHMIDT K, LEPPIN N, et al. The difficulties in end-of-life discussions-family inventory (DEOLD-FI): development and initial validation of a self-report questionnaire in a sample of terminal cancer patients[J]. J Pain Symptom Manage, 2021, 62(3): e130-e138.

[19] 朱雅麟,石琳琳,李炎,等. 临终沟通障碍-家庭版量表的汉化及信效度评价[J]. 护理研究, 2024, 38(5):770-774.

[20] LEV E L, OWEN S V. A measure of self-care self-efficacy[J]. Res Nurs Health, 1996, 19(5):421-429.

[21] 钱会娟,袁长蓉. 中文版癌症自我管理效能感量表的信效度测评[J]. 中华护理杂志, 2011, 46(1):87-89.

[22] EPSTEIN N B, BALDWIN L M, BISHOP D S. The Mcmaster family assessment device[J]. Journal of Marital and Family Therapy, 1983, 9:171-180

[23] 李荣风,徐夫真,纪林芹,等. 家庭功能评定量表的初步修订[J]. 中国健康心理学杂志, 2013, 21(7):996-1000.

[24] VON BLANCKENBURG P, RIERA K J, HOFMANN M, et al. Expectations, end-of-life fears and end-of-life communication among palliative patients with cancer and caregivers: a cross-sectional study[J]. BMJ Open, 2022, 12(5): e58531.

[25] 程春燕,张阳,陈欣怡,等. 老年癌症患者恐惧疾病进展与希望水平的相关性研究[J]. 护理学杂志, 2019, 34(1):13-16.

[26] SIMINOFF L A, ZYZANSKI S J, ROSE J H, et al. The cancer communication assessment tool for patients and families (CCAT-PF): a new measure[J]. Psychooncology, 2008, 17(12):1216-1224.

[27] 刘凯莉. 晚期癌症患者安宁疗护感知与需求量表的汉化及应用[D]. 新乡:新乡医学院, 2022.

[28] 朱雅麟,石琳琳,吴思雨,等.癌症患者死亡教育的研究进展[J].中西医结合护理, 2023, 9(6):236-243.

[29] 田丽,李梦媛,肖抒情,等. 晚期癌症患者预期性悲伤的现状及影响因素分析[J]. 护理学报, 2021, 28(7):11-14.

[30] 龙吉芳,黄旭倩,周娜,等. 308例癌症中年患者希望水平

中国知网 https://www.cnki.net

现状及影响因素分析[J]. 护理学报,2019,26(8):37-41.
[31] 施海霞,周瑜,杨玛,等. 安宁疗护对年轻结直肠癌晚期患者心理状况、死亡态度及生活质量的影响[J]. 皖南医学院学报,2025,44(3):279-283.
[32] RAFFERTY K A,CRAMER E M,PRIDDIS D. Managing end-of-life uncertainty: applying problematic integration theory to spousal communication about death and dying[J]. Am J Hosp Palliat Care,2016,33(1):69-76.
[33] 黄培雯,贺学宇,杨剑,等. 国内肿瘤患者灵性需求影响因素的Meta分析[J]. 现代临床护理,2023,22(1):68-76.
[34] 张琳榆,梁文丽,吴燕楠,等. 家庭适应性对乳腺癌患者复发恐惧的影响:心理弹性的遮掩效应[J]. 军事护理,2022,39(12):34-37.
[35] BALIN L,DAVIDSON Z,GROSS B,et al. Healthcare provider's culture and its impact on end-of-life discussions[J]. Omega(Westport),2024,88(4):1349-1368.
[36] SCHERER J S,SWIDLER M A. Decision-making in patients with cancer and kidney disease[J]. Adv Chronic Kidney Dis,2014,21(1):72-80.
[37] 黎东梅,陈锦丽,李丽,等. 300名慢性病患者代理决策者预立医疗照护计划参与现状及影响因素分析[J]. 护理学报,2023,30(2):67-72.
[38] 乔梦圆,闫欣雪,王海燕. 护士参与终末期患者临终决策的研究进展[J]. 护理学杂志,2023,38(1):117-120.
[39] 华兴龙. 乳腺癌患者需求、自我效能对生命质量的影响研究[D]. 延吉:延边大学,2022.
[40] 胡方舟,赵瑞芳,白杨,等. 多病共存患者自我效能对生活质量的影响:坚毅品质的中介作用[J]. 解放军护理杂志,2022,39(5):18-21.
[41] MANNE S L,KASHY D A,KISSANE D W,et al. Longitudinal course and predictors of communication and affect management self-efficacy among women newly diagnosed with gynecological cancers[J]. Support Care Cancer,2020,28(4):1929-1939.
[42] 李婕妤. 结直肠癌患者-配偶照顾者间沟通的影响因素及治疗性沟通系统的干预效果研究[D]. 无锡:江南大学,2021.
[43] 孙海燕,秦阳,徐益荣,等. 癌症患者及其配偶二元应对与心理弹性的主体-客体互倚模型研究[J]. 护理学报,2022,29(6):60-64.
[44] 徐瑞,李秋芳,郭菲菲,等. 生命意义寻求和体验在肺癌患者家庭功能与死亡焦虑间的中介效应[J]. 解放军护理杂志,2021,38(10):16-19.

[本文编辑:刘晓华]

·编读往来·

医学类论文中数字的用法

阿拉伯数字使用规则:①凡是可以使用阿拉伯数字且很得体的地方,均应使用阿拉伯数字;②公历世纪、年代、年、月、日和时刻必须使用阿拉伯数字,年份不能简写;③计量单位前的数字和统计表中的数值一律使用阿拉伯数字;④多位数的阿拉伯数字不能拆开转行。

汉字数字的用法:①数字作为词素构成定型词、词组、惯用语、缩略语或具有修辞色彩的词句,应使用汉字,例如十二指肠等;②邻近的两个数字并列连用表示概数时,应使用汉字,连用的两个数字之间不加标点,如三四家医院等;③不定数次一律用汉字,例如任何一例患者,无一例死亡。

参数与偏差范围的表示:①数值范围号的使用应统一,一般使用浪纹连接号"~";②单位相同的参数范围,只需写出后一个参数的单位,例如:35~45℃;③百分数范围的前一个参数的百分号不能省略,例如50%~60%。

[本刊编辑部]

中国知网 https://www.cnki.net